**Établissement**

**Médecin responsable**

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

# Hyperglycémie du patient diabétique

Adulte et enfant diabétiques · le PAI ou le plan de diabétologie prime

**URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT** · trouble de conscience, respiration rapide et profonde (Kussmaul), vomissements répétés, marbrures, PAS < 100 mmHg ; **cétonémie ≥ 3 mmol/L** (BU +++), ou ≥ 1,5 et médecin injoignable.

## J'applique si

- Glycémie capillaire **> 3 g/L** (16,5 mmol/L) ou « HI » ; > 2,5 g/L avec soif, polyurie, nausées, ou DT1 / pompe.
- Sous **gliflozine** : nausées, vomissements, douleur abdominale, dyspnée, **quelle que soit la glycémie**.

## Je ne fais pas

- **Insuline de correction** sans schéma nominatif signé.
- **Sauter l'insuline basale**, même si la personne mange peu.
- Modifier les réglages d'une **pompe** (panne = avis immédiat).

## J'agis

RÔLE PROPRE

1. **Recontrôle** sur un autre doigt lavé à l'eau.
2. **Cétonémie capillaire** (à défaut BU) : conduite selon la carte ci-contre.
3. PA, FC, FR, T°, SpO2, conscience, hydratation, diurèse.
4. Cause : **infection** (BU, T°, pied), oubli d'insuline, pompe, corticoïde ; gliflozine, metformine ?
5. **Hydratation per os** répétée (eau gélifiée si besoin), sauf restriction prescrite.

SUR CE PROTOCOLE

6. **Insuline rapide** seulement selon le **schéma nominatif signé**.

SUR AVIS MÉDICAL

7. Insuline hors schéma, hydratation SC ou IV, suspension d'une gliflozine ou de la metformine.

*Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.*

## Cétonémie (BU)

**< 0,6** (0, traces) → recontrôle à 2 h

**0,6–1,4** (+) → avis **dans l'heure**, contrôle à 1 h

**1,5–2,9** (++) → avis **sans délai** (15 si injoignable)

**≥ 3** (+++) → **15**

## J'appelle le médecin

- > 3 g/L persistante à 2 h ; gliflozine avec cétose.
- Fièvre, refus de boire, pompe défaillante ; 2–3 g/L répétées.

## Je surveille et je trace

- Glycémie et cétones **1 h** après correction, puis **toutes les 2 h** jusqu'à < 2,5 g/L et cétones < 0,6.
- Glycémies, cétones, apports, insuline (dose, heure), avis.
- Nuit sans IDE : l'AS/AP mesure la glycémie, appelle l'IDE si > 3 g/L ; aucune insuline par l'AS/AES.

**À retenir :** L'hyperglycémie se traite d'abord par sa cause et l'hydratation. Pas d'insuline « à vue » ; jamais de basale sautée.

Fait à : .....  Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Références : Fiche 0 ARS IDF/SGGIF 2016 (> 3 g/L) ; ASSURE IDF 2023, fiche D (> 2 g/L = alerte) ; Fédération française des diabétiques (cétones si > 2,5 g/L) ; ISPAD 2022, maladies intercurrentes (cétonémie 0,6 / 1,5 / 3 mmol/L) ; OMéDIT Grand Est, fiche réflexe hyperglycémie (03/2026) ; HAS, réponse rapide diabète (04/2020) ; EMA, RCP Jardiance (acidocétose, rubrique 4.4) ; arrêté du 26/06/2026 (actes IDE), art. 1 II.

Réf. DOTR-IDE-HYPER | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature